

ITEM 225 : ARTÉRIOPATHIE DES MEMBRES INFÉRIEURS

ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

AOMI = Présence de lésions d'athérosclérose significative **au niveau de l'aorte et des artère(s)** du membre inférieur : peut entraîner des plaques, sténoses ou obstructions athéromateuses

- Prévalence augmente avec l'âge : **> 20% après 70 ans**

- FDR CV : **tabac** (jeune ++), **diabète** (formes graves d'emblée, plus distales sévères), cholestérol, HTA, âge, sexe masculin

- **Dépistage** (pouls, auscultation des trajets vasculaires, IPS) :

. > 60 ans, > 50 ans avec FDR d'athérome, > 40 ans avec diabète

. Ou en cas d'autre localisation athéromateuse ou en cas de dysfonction érectile (oblitération aorto-iliaque)

- Mortalité : **15% à 5 ans** au stade de claudication, **25% à 1 an** au stade d'ischémie permanente

Etiologie la plus fréquente = maladie athéromateuse : expression locale d'une maladie systémique (3° localisation athéromateuse), pronostic selon lésions carotidiennes / coronariennes associées

Rappel des FdR CV : tabac, diabète, âge > 50 ans chez les hommes et > 60 ans chez les femmes, sexe masculin, dyslipidémie, obésité, antécédent familiaux CV précoces (avant l'âge de 55 ans pour les apparentés au 1er degré masculin, de 65 ans pour les apparentés au 1er degré féminin)

		Classification	Symptômes / IPS
Classification		Asymptomatique (le plus fréquent)	Abolition d'un pouls, $\searrow$ IPS < 0,90 /!\ Possible atteinte sévère asymptomatique : circulation collatérale importante, absence de marche (comorbidités du sujet âgé), neuropathie altérant la sensibilité (âge, diabète, IR)
		Ischémie d'effort	IPS < 0,90 + Pression cheville > 50 mmHg Claudication intermittente = Crampe musculaire à l'effort d'apparition progressive au bout d'un certain périmètre de marche (PM : distance de gêne, constante), majorée en marche rapide ou en côte, obligeant le sujet à s'arrêter (distance de marche), cédant à l'arrêt en < 5 minutes
		Ischémie critique Classification	Douleur de décubitus (symptômes au repos) / troubles trophiques + IPS < 90 + Pression cheville $\leq$ 50 mmHg ou Pression orteil $\leq$ 30 mmHg Tableau clinico-hémodynamique engageant le pronostic vital du membre (ischémie critique)
Diagnostic	Clinique		Interrogatoire : antécédents et FdRCV, symptômes (peut être asymptomatique) : douleurs à la marche, douleur permanente - Dysfonction érectile : fréquente, peut révéler la maladie athéromateuse : chercher une AOMI si terrain vasculaire → Syndrome de Leriche (oblitération complète du carrefour aortique) : claudication intermittente, douleur fessière bilatérale, impuissance et abolition des 2 pouls fémoraux - Diminution ou abolition des pouls périphériques - Souffle vasculaire artériel témoin d'une sténose - Recherche d'anévrisme abdominal et au creux poplité - Allongement du temps de recoloration cutanée > 3s au niveau du pied et des orteils - Au stade d'ischémie permanente : . Membre froid, pâle ou cyanosé ou érythrocyanose de déclivité +/- œdème de déclivité, . Déshabitation des pulpes digitales/coques talonnières, . Troubles trophiques : peau mince, froide, pâle, cyanosée, dépilée, fissures interdigitales ; ulcère artériel, gangrène nécrose cutanée, surinfection
		Index de pression systolique	= PAS de cheville/PAS du bras (la plus élevée entre les deux bras) = 0,9 à 1,4 chez le sujet sain - Examen de 1 ^{ère} intention, très fiable, facile (brassard tensionnel et doppler de poche) - En cas de diabète ou d'IRC → mesure au 1^{er} orteil (pression digitale) . Résultat : - < 0,90 : AOMI - > 1,40 : médiacalcose (diabète, âgé, IRC) → mesure au 1^{er} orteil
		Mesures de pression	- En cas de symptômes au repos, pression de cheville et pression au gros orteil : - Pression au gros orteil (digitale) à utiliser si diabète / IRC / grand âge / IPS > 1,4 - Ischémie permanente (symptômes de repos) si . Pression de cheville < 50 mmHg . Pression de gros orteil < 30 mmHg
Diagnostic	PC	Test de marche	- Distance de gêne et distance de marche sur tapis roulant - Réévaluation de l'IPS/P° de cheville avant et après la marche = épreuve de Strandness : une baisse > 30 mmHg ou > 20% de l'IPS après la marche est évocatrice d'AOMI
		Mesure de la TcPO₂	- En cas de symptômes au repos, mesure transcutanée de la pression en O₂ au dos du pied - Valeur : - Normale > 50 mmHg - < 30 mmHg : hypoxie = ischémie permanente chronique



Diagnostic		Echo-Doppler artériel	De l'aorte et des membres inférieurs : examen de 1 ^{ère} intention (non invasif) - Localisation et type de lésion (sténose, occlusion), flux hémodynamique : identification des lésions et de leur sévérité dans la grande majorité des cas + bilan topographique.	
		Autres techniques d'imagerie	= Uniquement si indication de revascularisation, en seconde intention : . Angioscanner = en 1 ^{ère} intention : bilan pré-interventionnel . Angio-IRM si CI au scanner, ne visualise pas les calcifications (pré-pontage) . Artériographie = uniquement si procédure de revascularisation percutanée	
		Bilan des FdRCV	Recherche de dyslipidémie / diabète / IR chronique - Glycémie à jeun, HbA1c, bilan lipidique ± microalbuminurie si patient diabétique - NFS, urée, créatinémie, uricémie - ECG de repos +/- d'effort	
DD	Douleurs à la marche	- Claudication veineuse (post-thrombotique) : sensation progressive de gonflement douloureux n'obligeant pas à l'arrêt de l'effort, distance d'apparition variable, récupération lente - Claudication rhumatologique = arthrose, rhumatisme, séquelle de traumatisme : douleur dès le début de la marche d'emblée maximale, de topographie articulaire, généralement vraie claudication (boiterie), récupération lente - Claudication neurologique médullaire (arthrose lombaire, canal lombaire étroit...) : délai d'apparition variable, soulagée par l'antéflexion, topographie radiculaire, récupération lente,		
Complications	Locales	Evolution à bas bruit : risque de diagnostic trop tardif pour revasculariser (amputation) -Ulcères, troubles trophiques, gangrène - Ischémie aiguë (évolution <15 jours) par embole artériel		
	Générales	- Décompensation de diabète - Complications coronariennes (SCA) / cérébrovasculaires (AVC) qui conditionnent le pronostic vital		
TTT	Dans tous les cas : contrôle des FdRCV, TTT médicamenteux, suivi régulier, activité régulière Si claudication : réhabilitation à la marche ± revascularisation si échec / lésion menaçante Si symptômes de repos : sauvetage du membre : revascularisation +++ voire amputation, prise en charge multidisciplinaire des troubles trophiques, traitement de la douleur/infection/dénutrition			
	Mesures médicamenteuses	- Contrôle des FdRCV : arrêt du tabac, traitement de l'HTA, équilibration du diabète... - Statine systématique même sans dyslipidémie - IEC/ARA 2 systématique si même en l'absence d'HTA - Antiagrégant plaquettaire systématique		
	Mesures associées	- Réhabilitation à la marche indispensable : ++ si claudication : programme personnalisé, auto-entraînement à domicile ou centre supervisé : développement de collatérales / augmentation distance de marche - Éducation thérapeutique - Prévention des troubles trophiques et ulcère : éviter les traumatismes, bonne hygiène, SAT/VAT		
	REVASCULARISATION	En cas de symptôme au repos +++ : sauvetage du membre, revascularisation la +complète possible En cas de claudication : surtout en sus-inguinal / sur la lésion la + significative, indiquée si : - Lésions avec claudication persistante invalidante malgré une prise en charge médicale optimale pendant 6 mois - D'emblée ou plus précocement en cas de lésions menaçantes (localisation / retentissement hémodynamique)		
		Angioplastie endoluminale percutanée	= Artériographie percutanée, dilatation au ballonnet ± stent Le plus souvent réalisé	
		Chirurgie	Pontage ou endartériectomie	
	Amputation	- Indication : En cas de persistance de l'ischémie malgré la revascularisation ou de situation locale engageant le pronostic vital (nécrose extensive, infection)		
	Suivi	- Adhésion à la réadaptation, aux prescriptions... - Obtention des cibles thérapeutiques : . LDL < 1,4 mmol/L (0,55 g/L), . TA < à 130/80 mmHg ou 140/80 mmHg chez les > 65 ans, . Contrôle glycémique, sevrage en tabac - Tolérance des TTT / efficacité, perméabilité des revascularisations		

ISCHÉMIE AIGUË DES MEMBRES INFÉRIEURS

Ischémie aiguë de membre = occlusion brutale d'un axe artériel des MI (< 15 jours) responsable d'une hypoxie pouvant aboutir à une nécrose tissulaire : **douleur intense++**, **urgence médico-chirurgicale absolue**
 → **Pronostic sombre** malgré prise en charge : 10% de décès, 25% d'amputation, 15% de séquelles et 50% de bons résultats.

Étiologie	Embolie sur artères saines (40%)	= Classiquement chez un sujet jeune, sans atcd vasculaire connu, avec un tableau brutal, aigu et sévère - Migration d'un caillot d'origine cardiaque ou aortique - Début très brutal, ischémie rapidement sensitivo-motrice et pouls périphériques controlatéraux présents, absence d'artériopathie connue, découverte d'une arythmie cardiaque - Rechercher l'atteinte embolique d'un autre territoire artériel (cérébral, rénal, splénique...) → Les embolies sur artère saine sont plus graves (absence de circulation collatérale)	
	Thrombose (60%)	Sur artère pathologique (le plus souvent) ou sur artère saine (rarement) Début plus progressif, ischémie moins sévère (suppléance vasculaire développée) Antécédents d'artériopathie des membres inférieurs, rythme sinusal	
Diagnostic	C	→ Le diagnostic est CLINIQUE → Le critère de gravité est la PARALYSIE : si pas de déficit moteur = « ischémie incomplète » - Douleur aiguë du MI : spontanée, brutale ou vite progressive, intense à type de crampe ou broiement avec impotence fonctionnelle - Membre froid, livide, cyanosé, veines superficielles collabées - Abolition des pouls en aval de l'occlusion : permet d'identifier la topographie <u>Signes de gravité :</u> - Atteinte neurologique : anesthésie, paralysie (nerf fibulaire commun ++ : impossibilité de relever le pied) - Atteinte musculaire : douleur à la palpation des masses musculaires (ischémie) - Nécrose cutanée à un stade avancé → 6P (Pain, Palor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis, Perishing cold)	
	EC	N'apportent rien au diagnostic positif (clinique) : ne retardent pas la prise en charge	
TTT	→ Hospitalisation en urgence en service de chirurgie vasculaire + voie veineuse, scope ECG, saturation Urgence absolue : tout retard expose au risque d'amputation voire de décès :		
	TTT symptomatique	→ Dès la suspicion du diagnostic - Anticoagulation curative par HNF dès le diagnostic : pour éviter l'extension du thrombus et la récurrence embolique - Antalgique de niveau 3 souvent d'emblée , à adapter après revascularisation - Prise en charge d'un bas débit cardiaque, hypovolémie, troubles du rythme. - Soins locaux (nursing) : risque d'escarres / nécrose : protection mousse ou coton, position légèrement déclive, éviction de tout frottement ou traumatisme cutané, proscrire tout adhésif	
	REVASCULARISATION	Avant la 6 ^e heure (après : risque d'amputation majeur) Geste guidé par artériographie préalable au bloc opératoire	
		Embolie sur artère saine	- Embolectomie par sonde de Fogarty
		Thrombose ou embolie sur artère pathologique	- Technique endovasculaire : recanalisation, thromboaspiration, angioplastie - Thrombolyse in situ par voie intra-artérielle (long délai = 12-24h) : si lit d'aval de mauvaise qualité et ischémie peu sévère (absence de trouble neurologique) - Technique chirurgicale : pontage/endartériectomie (le plus souvent distal)
	Autre	- Lavage de membre discuté si revascularisation tardive ou thrombose aorto-iliaque en prévention d'un syndrome de revascularisation - Aponévrotomie de décharge au moindre doute de syndrome de loge ou revascularisation tardive - Amputation si ischémie dépassée (rigidité musculaire, marbrures cutanées, phlyctènes) ou après échec de revascularisation/pour juguler un syndrome de revascularisation majeur - Traitement étiologique : étiologie à rechercher : cause cardio-embolique notamment++	
	Surveillance	- Clinique : masse musculaire, pouls, température, diurèse, cicatrice ; monitoring ECG continu - Reperfusion : ↳ douleur, recoloration cutanée, état du MI, état du point de ponction - Bio : NFS, plaquettes, iono, GDS, fonction rénale, bilan hépatique, hémostase, enzymes musculaires - Echographie-Doppler artériel de contrôle	
		Syndrome de reperfusion	= La lyse cellulaire induite par l'ischémie, entraine lors de la revascularisation le rejet dans la circulation sanguine de potassium et de myoglobine - Troubles métaboliques : hyperkaliémie, acidose lactique, hyperuricémie, myoglobininémie/urie, IRA, hypocalcémie, hyperphosphorémie , voire CIVD - Détresse respiratoire possible - Troubles du rythme cardiaque possibles jusqu'à l'ACR : favorisé par l'hyperkaliémie, l'acidose...